Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Estrela

Rua Pinheiro Machado, 285 - Bairro: Centro - CEP: 95880000 - Fone: (51)3098-5398 - Balcão Virtual: (51) 99515-5879 - Email: frestrela2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000943-33.2017.8.21.0047/RS

AUTOR: VANESSA FIORIO

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

VANESSA FIORIO ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** , já qualificados. Narrou, em suma, que diagnosticado(a), conforme atestados médicos e exames apresentados, com a patologia classificada com a CID 10 I27.2. Referiu que necessita fazer uso do medicamento Riociguate, conforme prescrição médica. Asseverou que não logrou êxito na dispensa administrativa dos fármacos e que não possuí condições de adimplir com o custo. Apresentou os fundamentos jurídicos que entende adequados. Em antecipação de tutela, postulou que o demandado seja compelido em disponibilizar o bem de saúde. Requereu, no mérito, a confirmação da liminar, com condenação do demandado. Pediu gratuidade da justiça. Juntou documentos (evento 2, PROCJUDIC2).

Recebida inicial, deferida gratuidade da justiça e a antecipação de tutela (evento 2, PROCJUDIC3 - p 51)

O Estado do Rio Grande do Sul contestou (evento 2, PROCJUDIC3 - p 63 e evento 2, PROCJUDIC4). Em preliminar, ventilou a incidência da denominação comum brasileira. No mérito, teceu comentários sobre o artigo 196 da Constituição Federal, os princípios regentes do SUS, a judicialização da saúde, bem como os princípios da legalidade e independência dos poderes, aplicáveis ao direito à saúde.Indicou a legislação que entende adequada ao caso. Propugnou pela improcedência.

Deferida alteração de dosagem e determinada realização de perícia (evento 2, PROCJUDIC5 - p 28)

Constrições de valores com prestações de contas (evento 2, PROCJUDIC6 a evento 2, PROCJUDIC15)

Determinada inclusão da União no polo passivo, com declinação da competência (evento 2, PROCJUDIC16 - p 11).

A Justiça Federal devolveu os autos (evento 47, DESPADEC1)

Fixada competência da Justiça Federal (evento 115, DESPADEC1).

Citada, a União Federal contestou (evento 147, CONT1). Ventilou, em preliminar, a incompetência da Justiça Federal e a ilegitimidade, bem como desinteresse no litígio. Discorreu acerca do direito fundamental à saúde. Indicou a legislação que entende pertinente. Pediu o acolhimento da preliminar ou, no mérito, improcedência.

Réplica (evento 153, RÉPLICA1)

Retornados os autos ao Juízo Estadual (evento 254, DESPADEC1)

Excluída União do polo passivo (evento 275, DESPADEC1)

Nota técnica ENatjus (evento 323, NOTATEC1 e evento 337, NOTATEC1)

As partes, intimadas, não requereram outras provas (evento 344, PET1 e evento 346, PET1)

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O direito fundamental social à saúde vem assegurado nos artigos 6º, caput, e 196, ambos da Constituição Federal de 1988. Dispõe a Constituição ser dever do Estado (sentido amplo) prestar as ações e serviços necessários, por meio de políticas públicas, à promoção, proteção e recuperação da saúde do cidadão.

Ademais, o artigo 2º da Lei Federal nº 8.080/90 dispõe que "*a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".*

Cediço que o direito à saúde pode ser classificado dentre aqueles considerados fundamentais, de caráter social (artigo 6º da Constituição Federal), verdadeiro corolário do direito à vida. Como tal, aplica-se-lhe a regra do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal*: "as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata*".

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

Além dos dispositivos constitucionais, a Lei Federal nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso, também possui previsão expressa ao direito à saúde, em seu art. 15, ao referir que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do SUS. E, ainda, no § 2º do mencionado art. 15 ao aduzir que incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o dever do Estado, *lato sensu* considerado, ou seja, modo indistinto por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23, II e 196, ambos da Constituição Federal. Neste sentido: RE nº 557.548/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 155, publicado em 05.12.2007. Observo, inclusive, que o STF, quando da fixação de tese no Tema 793/STF, reafirmou, incontroversamente, a presença da solidariedade entre os Entes Públicos na prestação de assistência à saúde pública à população.

Especificamente quanto ao direito à vida, indiscutível que sem este nenhum outro direito se perfectibiliza, sendo o bem maior do cidadão a ser protegido pelo Estado.

Nessa esteira, observo que não tendo o Poder Público cumprido com o seu papel de assegurar à parte o acesso ao serviço ou bem de saúde de que necessita, resta autorizada e necessária a intervenção do Poder Judiciário, no sentido de verificar a situação e fazer cumprir as disposições legais e constitucionais, não se cogitando, com isso, desrespeito ao princípio da independência dos poderes ou ao poder discricionário do administrador. A administração pública não pode se escudar em sua discricionariedade para afastar do Poder Judiciário a análise de fatos envolvendo violação de direitos.

Ademais, ainda, acerca do papel do Poder Judiciário diante das demandas que veiculem pretensão à concretização de um direito fundamental, ensina Paulo Gustavo Gonet Branco:

> *"Cabe ao Judiciário a tarefa clássica de defender os direitos violados ou ameaçados de violência (art. 5º, XXXV, CF). A defesa dos direitos fundamentais é da essência da sua função. Os tribunais detêm a prerrogativa de controlar os atos dos demais Poderes, com o que definem o conteúdo dos direitos fundamentais proclamados pelo constituinte. A vinculação das cortes aos direitos fundamentais leva a doutrina a entender que estão elas no dever de conferir a tais direitos máxima eficácia possível. Sob um ângulo negativo, a vinculação do Judiciário gera o poder-dever de recusar aplicação a preceitos que não respeitem os direitos fundamentais". Curso de Direito Constitucional. 4º ed. São Paulo : Editora Saraiva, 2009, p. 284.*

Ante, o dever de conferir máxima eficácia possível aos direitos fundamentais, estes tornam-se direito subjetivo e, havendo omissão estatal na adoção de políticas públicas para o cumprimento de uma prestação em matéria de saúde, possível ao Judiciário determinar, pontualmente, a satisfação do direito.

Contudo, tal direito subjetivo público não deve ser confundido com direito a uma prestação individual ou exclusiva, pois, ainda que satisfeito um conjunto destas prestações, estas não equivalem, pelo seu alcance restrito, atomizado e, sobretudo, individual, à concretização de uma política pública, caracterizada pela amplitude, generalidade e caráter coletivo.

Passo ao exame das provas, a fim de verificar se preenchidos os pressupostos acima estabelecidos para o atendimento da pretensão da parte autora.

No caso, considerando os documentos médicos e demais documentos que instruíram o feito, tenho bem demonstrados os fatos narrados na inicial, restando comprovada a necessidade de fornecimento do medicamento.

Acerca da importância do fármaco, translado o parecer técnico do evento 337, NOTATEC1:

Conclusão

Tecnologia: RIOCIGUATE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Esta presente nota técnica (NT) é complementar à NT 210391, submetida em 04/04/24.
CONSIDERANDO o diagnóstico da paciente de hipertensão pulmonar por tromboembolismo crônico (CTEPH), conforme os documentos acostados na solicitação.

CONSIDERANDO o relato de que a paciente mantém-se sintomática na vigência de tratamento e após tromboendarterectomia realizada em 19/06/18.
CONSIDERANDO o resultado do cateterismo direito realizado em 13/01/23 que evidenciou hipertensão arterial pulmonar grave por componente pré-capilar.
CONSIDERANDO o resultado de ecocardiograma realizado em 17/11/23 com elevada pressão sistólica da artéria pulmonar (100mmhg), em progressão ao se comparar com exames prévios que foram descrito em relatório médico.
CONSIDERANDO o resultado de angiotomografia de tórax datada de 29/08/2023, cujo laudo descreve sinais sugestivos de embolia pulmonar crônica.
CONSIDERANDO a cintilografia pulmonar fase de perfusão, feita em 17/11/23, com anormalidades sugestivas de tromboembolismo pulmonar.
CONSIDERANDO que, diante da natureza rara e severa da hipertensão arterial pulmonar, da limitação das opções terapêuticas às elencadas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como da existência de suporte científico que corrobora a indicação (previamente aprovada para esta paciente) do medicamento pleiteado e dos perigos inerentes à interrupção do tratamento, e considerando os documentos vinculados aos autos, este parecer manifesta-se favoravelmente à continuação da dispensação excepcional do fármaco Riociguate à paciente em tela.
CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS para sustentar a indicação da medicação solicitada (RIOCIGUATE), no presente caso. Embora, **NÃO** se caracterize **urgência**, conforme definido pelo CFM, enseja brevidade pelas características do caso. Cabe a ressalva de que os membros do Plenário presentes na 105ª Reunião Ordinária, no dia 10 de fevereiro de 2022, deliberaram, por unanimidade, sem nenhuma declaração de conflito de interesse, recomendar a não incorporação do riociguate para Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) inoperável, persistente ou recorrente após tratamento cirúrgico. Considerou-se as incertezas quanto aos benefícios do riociguate para a indicação proposta; a sua razão de custoefetividade incremental e o seu impacto orçamentário estimado, além da ausência de contribuição que pudesse modificar a recomendação preliminar. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 704/2022.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

A par do caso concreto, com mesmo medicamento, cito:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIOCIGUATE (ADEMPAS) OBSERVÂNCIA DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DEFERIDA PELO STF NO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA 1234). ALTO CUSTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178/PE (TEMA 793), reafirmou o entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais na área da saúde. 2. No entanto, ainda paira alguma controvérsia jurídica sobre a interpretação do alcance da tese fixada pelo STF no Tema 793 e pelo STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 14. Por conta disso, o STF admitiu repercussão geral no RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234), tendo o Min. Gilmar Mendes, na tutela provisória incidental deferida em 17.04.2023 (referendada pelo Pleno do STF em sessão virtual realizada no dia 18.04.2023), estipulado alguns parâmetros para o julgamento das ações de saúde em âmbito nacional. 3. O laudo médico juntado com a inicial informou que os tratamentos anteriores, com fármacos disponíveis no SUS, não surtiram efeito, além de que a "doença da paciente é grave, progressiva e há risco de morte e falência cardíaca direita". 4. O medicamento "Riociguate (Adempas)", conforme já decidiu este Tribunal, não é padronizado. 5. Na situação dos autos em que a demanda objetiva o fornecimento de medicação não incorporada ao SUS e a sentença foi prolatada em data posterior a 17/04/2023, tem aplicação o parâmetro (ii) da decisão na tutela provisória incidental (Tema 1234), sendo prescindível a inclusão da União no polo passivo, devendo o feito ser julgado pelo juízo ao qual foi direcionado pelo cidadão, conforme orienta a jurisprudência recente desta Corte e das Turmas Recursais da Fazenda Pública. 6. No tocante ao alto custo do medicamento, é importante ressaltar que o STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE nº 566.471/RN, da relatoria do Min. Marco Aurélio, isto é, discute-se o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo. O STF concluiu o julgamento em 11/03/2020, tendo o Tribunal, por maioria, negado provimento ao recurso extraordinário, vencido parcialmente o Ministro Edson Fachin, que lhe dava parcial provimento. Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior; razão pela qual deve ser mantido o entendimento consagrado nesta Corte no sentido de que o alto custo do medicamento não tem o condão de afastar o dever constitucional do ente público de fornecê-lo. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50016156020198210018, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-02-2024)*

No sentido da impossibilidade de custeio, sem prejuízo da própria subsistência, afora a ausência de impugnação na contestação, o teor do documento do contracheque é indicativo de que se trata de parte de baixa renda.

Destaca-se que nenhum documento constante nos autos foi objeto de impugnação, nenhuma prova tendo postulado o(s) réu(s) no sentido de elidir a necessidade dos serviços/bens de saúde ou mesmo eventual carência de recursos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido deduzido por **VANESSA FIORIO** para **DETERMINAR** ao **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** o fornecimento do medicamento **RIOCIGUATE,** observada a denominação comum brasileira, em favor da parte autora,

conforme prescrição médica ou alcançar os equivalentes em dinheiro, sob pena de ordem de bloqueio de valores em caso de descumprimento, enquanto perdurar a necessidade.

A prescrição médica deverá ser atualizada semestralmente, salvo se outra periodicidade for estabelecida administrativamente, junto ao ponto de distribuição de medicamentos da Secretaria de Estado da Saúde – Farmácia de Medicamentos Especiais ou outro local – pois há necessidade de acompanhamento do tratamento para verificação do uso efetivo e do resultado apresentado. A não atualização do receituário acarretará a suspensão do fornecimento pela Farmácia do Estado até que ocorra a regularização e impedirá a apreciação de eventual pedido de bloqueio de valores.

Confirmo a tutela de urgência deferida e a gratuidade judiciária.

No mais, com homologação da parte ré, julgo boas as contas prestadas nos autos. **Expeça-se alvará de eventual saldo em favor do Estado do Rio Grande do Sul.**

Custas pelo demandado, ficando isento da Taxa Única de Serviços Judiciais conforme a previsão do art. 5º, inciso I, da Lei Estadual nº 14.634/14, mas respondendo por eventuais despesas do processo pendentes.

Condeno o demandado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. Salienta-se, de plano, que não se desconhece o Tema nº 1076 do STJ, razão pela qual consigno, desde já, que não há omissão, obscuridade ou contradição na fixação dos honorários. O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, com acumulado mensal, uma única vez, para fins de correção e juros de mora, a partir de 09/12/2021, conforme EC 113/2021.

Decisão não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se o recorrido para contrarrazões e, após, independentemente de conclusão, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça.

As partes ficam cientes, desde já, que eventual cumprimento de sentença (ainda que provisório) deve ser manejado em ação autônoma no Sistema EPROC, mas vinculado ao processo da fase de conhecimento, conforme Ofício Circular nº 077/2019-CGJ.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO DEZORZI, Juiz de Direito**, em 25/9/2024, às 15:51:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10065851464v8** e o código CRC **a899306b**.